

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0057

Paginas del documento: 8

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

e de sus propias capacidades. ntar las tensiones normales de actividades personales de forma productiva y fructífera, lo que le permite contribuir a su comunidad. Estos lineamientos concuerdan con los del Ministerio de Salud (MINSAL, 2014), que promueven óptimas condiciones psicosociales en el ámbito familiar, de la escuela y del trabajo, e integran una visión más sistémica del concepto convencional.

El concepto de calidad de vida ha tenido distintas definiciones a lo largo de las últimas décadas. En 1995 se creó The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL), un grupo de trabajo a cargo de la OMS que define *calidad de vida* como la percepción que tienen los individuos acerca de su posición en la vida dentro de un contexto cultural y su sistema de valores; asimismo, toma en cuenta cómo se relaciona con sus objetivos, expectativas, estándares e intereses (The WHOQOL Group, 1995).

Desde una perspectiva teórica, Urzúa y Caqueo (2012) hacen un barrido de las distintas definiciones del concepto. Destacan la de Ferrans (1990), que propone un concepto general enfocado en el bienestar de la persona, del cual se deriva la satisfacción o la insatisfacción de áreas afines a sus gustos; y la de Hörnquist (1982), que plantea que la calidad de vida incluye las necesidades físicas, psicológicas, sociales, materiales y estructurales, así como las actividades que realiza la persona. Además, Lawton (2001) indica que la calidad de vida es una evaluación multidimensional que se vincula a criterios personales y de la sociedad. Por último, Haas (2007), tal como Lawton, señala que es una evaluación multidimensional pero enfocada a circunstancias individuales en un contexto cultural y valórico.

Los distintos enfoques y consideraciones con respecto a la calidad de vida se relacionan estrechamente con las investigaciones en salud mental, que analizan el concepto con la finalidad de profundizar en las necesidades fisiológicas, culturales y sociales de los individuos.

Los resultados de los estudios sobre autorregulación del aprendizaje describen las diferencias entre los enfoques que existen sobre la temática, la calidad del proceso educativo que contemplan los estudiantes y las intervenciones relacionadas con la autorregulación al interior de los centros educativos (Dent & Koenka, 2015; De Smul et al., 2019a y 2019b; Heirweg et al., 2020). Las estrategias emocionales/afectivas son las más importantes para fomentar la autorregulación del aprendizaje del estudiantado (Barría et al., 2017; Díaz et al., 2017). No obstante, existen estudios que no lograron evidenciar cambios importantes y significativos que incidan positivamente en el bienestar de los alumnos (Vandeveldt et al., 2016; Villanueva et al., 2020; Zhou et al., 2023).

En lo que respecta a los estudios sobre la autopercepción del aprendizaje y su relación con la calidad de vida,

tores de protección del estudiantado (Orozco & García, 2017; Silva et al., 2021; Vaquero, 2022; Abate et al., 2024).

Hasta el año 2020, la salud mental se abordaba a través de un plan de salud mental a cargo del MINSAL (2017). Sin embargo, en 2021 se promulgó la Ley n.º 21331, para el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental. De este modo, basándose en lo establecido por la OMS, se reconoce como *salud mental* a un estado de bienestar, entendido como la capacidad de las personas adultas de desenvolverse de forma consciente en su vida cotidiana y aportar a la comunidad. En niños, niñas y adolescentes, por su parte, se entiende como un grado óptimo de funcionamiento y un bienestar psicológico. En ambos casos, la salud mental está determinada por diversos factores, que pueden ser culturales, históricos, socioeconómicos, biológicos y psicológicos (MINSAL, 2021).

Dichos factores han sido abordados en estudios de prevalencia que consideran patologías psiquiátricas de la población chilena y utilizan como objetos de estudio a niños y jóvenes. Estos estudios dejan en evidencia que el perfil epidemiológico de los trastornos mentales y del comportamiento en la población infantil chilena coincide, en términos generales, con el de otros países. Esta información ha permitido concluir que los trastornos del comportamiento son más frecuentes en edades tempranas (Vicente et al., 2010 y 2012). Ante esto, resulta relevante tener en cuenta la información del medio en que se desenvuelve el sujeto, su nivel de atención y la comprensión de sus cuidadores al dirigir sus acciones motoras, pues todos estos indicadores son evidencia de una regulación adaptativa del comportamiento (McClelland et al., 2000 y 2007; White et al., 2024).

Los objetivos de esta investigación fueron: 1. determinar el nivel de autorregulación, 2. determinar el nivel de autopercepción de calidad, 3. relacionar la autopercepción de calidad de vida y el riesgo psicosocial, 4. relacionar la autorregulación y el riesgo psicosocial, y 5. analizar la influencia de la autorregulación y la autopercepción de calidad de vida en el riesgo psicosocial de alumnos de 4.º año básico, beneficiados por el Programa Habilidades para la Vida (PHV) en la provincia de Concepción, región del Biobío. La pregunta de investigación fue la siguiente: ¿cuáles son los factores de riesgo y protectores asociados a la salud mental infantil a partir de la evaluación del riesgo psicosocial, la autorregulación emocional y la calidad de vida autopercebida en el estudiantado de enseñanza primaria?

La importancia de estudiar los factores asociados a esta área proviene del aumento de los problemas de salud mental en la última década, fenómeno que se presume está asociado a diversos fenómenos tales como la urbanización, la globalización, los cambios en la estructura familiar, el incremento de las exigencias vocacionales, el

e de encuestas según una naturaleza relacional-explicativa (Vieytes, 2004). Su objetivo fue analizar el riesgo psicosocial de estudiantes partícipes del PHV nacional de la JUNAEB. Los datos primarios tienen su origen en instrumentos estandarizados, que dieron origen a las variables “autorregulación emocional” y “autopercepción de calidad de vida”, mientras que los datos secundarios fueron extraídos de la base de datos nacional de la JUNAEB, y se convirtieron en la variable “riesgo psicosocial”.

Los participantes fueron estudiantes de 4.º año básico de establecimientos de las comunas de Concepción, Tomé y Florida, seleccionados de manera intencionada a través del acceso que brindó el PHV. Por estas razones, el muestreo tuvo un carácter no probabilístico de tipo intencionado, y alcanzó una muestra de 444 estudiantes, dado que no todo el estudiantado había participado del Cuestionario Pediátrico de Síntomas (PSC, por sus siglas en inglés) y del instrumento Teacher Observation of Classroom Adaptation-Revised and Reduced (TOCA-RR). Los alumnos se encontraban con un consentimiento y asentimiento firmado al momento del levantamiento de datos.

Los datos utilizados en la elaboración del estudio provienen de fuentes de información diferentes. En el caso de la variable dependiente (riesgo psicosocial), se configuró a partir de datos secundarios del año 2012, concretamente de los puntajes obtenidos en los instrumentos PSC y TOCA-RR. En cambio, las variables independientes (autopercepción de calidad de vida y autorregulación emocional) se obtuvieron a partir de datos primarios levantados en 2013.

TOCA-RR fue desarrollado para estudiar el comportamiento de los alumnos en programas preventivos de intervención en el aula (Kellam et al., 1975; Kellam & Rebok, 1992; Kellam & Van Horn, 1997), y es aplicado por los profesores jefes de curso. Evalúa seis dimensiones: contacto social, aceptación de la autoridad, madurez emocional, actitud hacia el aprendizaje, concentración y nivel de actividad. Presenta valores de confiabilidad (alfa de Cronbach) entre 0,74 y 0,95 para las distintas escalas, y refleja conductas desadaptativas específicas del niño. Estas conductas representan áreas en las que se observan problemas tempranos, con lo que constituyen antecedentes de riesgo para la salud mental futura del menor. El instrumento ha sido validado en el contexto nacional por el PHV, para su uso en salud mental escolar (George et al., 1994 y 2004).

El PSC fue desarrollado por Jellinek et al. (1988) para ser contestado por los padres de niños de entre 6 y 12 años. Proporciona un puntaje global que refleja la percepción parental sobre el funcionamiento psicosocial del niño. Fue validado por George et al. (1994) con el objetivo

Sexo	Mujer	63	(39,6 %)	35	(46,7 %)	104	(49,5 %)
	Hombre	96	(60,4 %)	40	(53,3 %)	106	(50,5 %)
Zona	Urbano	159	(100 %)	0	(0 %)	189	(90 %)
	Rural	0	(0 %)	75	(100 %)	21	(10 %)

Fuente: Autores (2025).

tres partes. La primera presentando con base en los estadísticos de segundo lugar, se lleva a cabo un análisis bivariado utilizando el estadístico *r* de Pearson para conocer la relación entre las variables del estudio. Por último, se evalúa el nivel de predicción del riesgo psicosocial de las variables independientes del estudio.

Características de los participantes

La edad promedio del alumnado de 4.º año básico que participó del estudio es 9,6 años, con una desviación de 0,76 y un rango entre 8 y 12 años. Los datos muestran que el estudiantado con riesgo psicosocial, identificado a partir de TOCA-RR, representa un 10,61 %, que son los participantes directos en todas las actividades del PHV. Un 89,6 % representa a alumnos beneficiados indirectamente por actividades del programa como las asesorías al aula y las asesorías para padres.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables “riesgo psicosocial”, “autorregulación emocional” y “autopercepción de calidad de vida”.

Variable	Media	Mediana	Desviación estándar	Mínimo	Máximo	N
Evitación del daño	9,43	9	3,51	1	19	444
Dependencia de recompensa	2,49	2	1,17	0	5	443
Persistencia	2,54	3	1,07	0	4	444
Autorregulación emocional	14,47	15	3,86	1	26	444
Actividad física y salud	3,53	3,6	0,63	1,25	4,6	444
Bienestar psicológico	3,38	3,42	0,38	1,71	4,86	444
Relación con los padres y autonomía	3,94	4,14	0,78	1,14	5	444
Apoyo social y de pares	4,29	4,5	1,06	1	17,5	444
Ambiente escolar	4,05	4,25	0,75	1,25	5	444
Autopercepción de calidad de vida	3,84	3,93	0,48	1,60	6,82	444
Riesgo psicosocial	100,9	99	31,6	26	192	444

Fuente: Autores (2025).

En la [tabla 2](#) se evidencia que, en promedio, los participantes tienen niveles moderados a altos de bienestar psi-

exactas utilizadas para medir estas variables y considerar el contexto de la muestra.

El análisis de correlaciones revela un entramado de relaciones significativas entre las variables psicosociales evaluadas y la autopercepción de la calidad de vida en la muestra estudiada (ver [tabla 3](#)). En general, se observa una clara tendencia: las variables que reflejan un bienestar psicológico, relaciones sociales positivas y un entorno favorable correlacionan positivamente con la autopercepción de la calidad de vida. Específicamente, la actividad física y la salud, el bienestar psicológico en sí mismo, una buena relación con los padres, la percepción de autonomía, el apoyo social proveniente de los pares y un ambiente escolar percibido como positivo exhiben correlaciones positivas y significativas con la forma en que los participantes evalúan su propia calidad de vida, lo que sugiere que estos factores actúan como pilares fundamentales que sostienen una percepción positiva de la vida.

En contraste, las correlaciones negativas sugieren que factores como un alto riesgo psicosocial pueden mermar la autopercepción de la calidad de vida, aunque es importante notar que la magnitud de estas correlaciones negativas es generalmente menor en comparación con las positivas. Es crucial considerar que las correlaciones no implican causalidad, y que estos vínculos podrían ser bidireccionales o estar influenciados por terceras variables no consideradas en este análisis. No obstante, estos hallazgos proporcionan información valiosa para identificar áreas clave de intervención que podrían mejorar la autopercepción de la calidad de vida en esta población, pues enfatizan la importancia de promover un entorno psicosocial saludable y relaciones interpersonales positivas.

Tabla 3. Correlación entre el riesgo psicosocial, la autorregulación emocional y la calidad de vida autopercebida.

	Riesgo psicosocial	Autorregulación emocional	Autopercepción de calidad de vida
Riesgo psicosocial	1		
Autorregulación emocional	0,63	1	
Autopercepción de calidad de vida	-0,19**	0,85	1

** *p* < 0,01 (significancia alta)
Fuente: Autores (2025).

Regresión lineal múltiple

El análisis de regresión buscó determinar si la relación con los padres y el ambiente escolar predicen el riesgo

nto a los supuestos de la regre-
Watson sugiere que no hay au-
La inspección de los valores de
tolerancia y del factor de inflación de la varianza indica
que no hay problemas de multicolinealidad. Sin embar-
go, la baja cantidad de varianza explicada sugiere que el
modelo está incompleto y que otros factores importantes
no están incluidos, lo que limita su poder predictivo.

Tabla 4. Regresión lineal múltiple de las variables “auto-
rregulación emocional” y “autopercepción de la calidad
de vida”, e indicadores de percepción de los padres sobre
el riesgo psicosocial.

	Constante	Beta no estandarizado	t	P
Constante	122,431		10,351	0,000
No posee hiperac- tividad en casa		-20,972	-3,946	0,000
Índice de visión positiva de los padres		-14,151	-3,358	0,001
Autopercepción de calidad de vida		-0,371	-3,709	0,000
Fantasia		1,440	2,035	0,043

Fuente: Autores (2025).

Considerando los coeficientes tipificados beta, la va-
riable “ausencia de hiperactividad en casa” ($\beta = -0,214$;
 $p = 0,000$; 95 % IC [-31,40; -10,51]) resultó ser el predi-
ctor más relevante para el modelo óptimo de explicación
del riesgo psicosocial. En segundo lugar, se encuentra el
índice de resiliencia ($\beta = -0,181$; $p = 0,001$; 95 % IC [5,85;
22,44]), luego la autopercepción de la calidad de vida
($\beta = -0,19$; $p = 0,000$; 95 % IC [-0,56; -0,17]) y, en último
lugar, la fantasía ($\beta = 0,11$; $p = 0,043$; 95 % IC [0,04; 2,83]).

Discusión

El propósito central de la investigación fue analizar los
factores de riesgo y protectores asociados a la salud men-
tal infantil, evaluando la relación entre el riesgo psicoso-
cial, la autorregulación emocional y la calidad de vida au-
topercibida en estudiantes de 4.º año básico beneficiarios
de un programa social (JUNAEB) en Concepción, Chile.
El estudio de la relación entre el riesgo psicosocial y la
autopercepción de la calidad de vida mostró una relación
significativa, baja y negativa. Los resultados son simila-
res a los de investigaciones previas que identifican los
factores de contextos y socioeconómicos con la capacidad
de incidir negativamente en la percepción de bienestar
de las poblaciones estudiantiles (Oyanadel et al., 2015;
Ruiz et al., 2017).
La relación entre la variable de riesgo psicosocial y la

unidades técnicas (Dent & Koenka, 2015; De Smul et al.,
2019a y 2019b; Heirweg et al., 2020).
En cuanto al modelo estadístico de riesgo psicosocial,
las variables relacionadas con los índices de percepción
de los padres sobre la hiperactividad y la resiliencia de
sus hijos obtuvieron una participación positiva en el mo-
delo empírico que se generó. Esto supone una reflexión
importante de los aspectos afectivos y conductuales del
riesgo psicosocial. A diferencia de la calidad de vida
autopercibida, que fue desarrollada teóricamente para
comprender el objeto de estudio, y que si bien participa
del modelo teórico-empírico no mostró ser un elemento
predictor alto, la valoración de los padres sí lo fue. Caso
aparte es lo sucedido con el componente de autorregula-
ción “fantasía”, que, si bien aportó al modelo empírico,
no aporta sustancialmente desde sus elementos a la com-
prensión de la variable dependiente del estudio.
Estos resultados evidencian la necesidad de com-
prender el riesgo psicosocial a través de una evaluación
multidimensional, enfocándose en contextos culturales y
valóricos (Lawton, 2001; Haas, 2007). De esta manera, es
posible enfocar modelos de trabajo que comprendan las
patologías psiquiátricas de la población infantil chilena
(Vicente et al., 2012).
Asimismo, se observó que el riesgo psicosocial se en-
cuentra mediado tanto por la percepción de los padres
sobre el desarrollo psicosocial del niño, como por las
valoraciones subjetivas de la persona sobre su bienestar
personal y su capacidad de sentirse una parte del todo
al tener una reflexión espiritual de sus acciones. De esta
forma, la calidad de vida autopercibida y uno de los
componentes de la autorregulación emocional se justifi-
can como factores importantes en el afrontamiento de los
factores de riesgo del contexto familiar y escolar, pues
se consideran como el punto de partida para reflexionar
sobre las actividades promocionales y preventivas que
desarrolla el PHV.
Estos aspectos, en su conjunto, permiten sostener que
el modelo transaccional de Sameroff (1994) y los facto-
res de riesgo analizados por Kellam et al. (1982) son una
visión válida para el análisis del riesgo psicosocial. Este
análisis multivariado permite alcanzar una comprensión
acabada del riesgo psicosocial: se observa que la influen-
cia de los padres, junto a variables personales del sujeto,
son determinantes claras de las conductas riesgosas o los
factores de riesgo a los cuales se ve expuesto el estudiante
en su desarrollo evolutivo.
Las limitaciones del estudio se relacionaron con el
uso de un muestreo intencionado que restringió la ge-
neralización de los resultados y con un diseño transver-
sal que impide establecer relacionales causales entre las
variables del estudio. Para futuras investigaciones, se
recomienda ampliar el tamaño y la heterogeneidad de
la muestra, así como incorporar diseños longitudinales

de riesgo psicosocial en el estu-
maria, subrayando la necesidad
articulen el apoyo comunitario,
mover el bienestar infantil.

En el futuro, las investigaciones asociadas al objeto de estudio podrían emplear diseños longitudinales con el propósito de explorar las trayectorias del riesgo psicosocial y sus factores protectores, al igual que las concepciones subjetivas de los diferentes actores relacionados con la autorregulación, el autocuidado y el riesgo psicosocial.

Referencias

Declaración de conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses financiero, académico o personal que pueda haber influido en la realización del estudio.

Declaración de ética

El presente estudio involucró la recopilación de datos de instituciones educativas a través de la Agencia de Calidad Educativa de Chile. Se garantizó el respeto a la privacidad y confidencialidad de la información recopilada. Todos los datos utilizados fueron obtenidos de una fuente pública e institucional. En este estudio no se involucró la participación directa de seres humanos, por lo que no se requirió consentimiento informado.